Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Eleonar Muñoz Perez.				Sexo	F ✓	M
Fecha Nacimiento	01-02-20	Edad actual	5 años	3 meses	País natal:	Chile.	
Domicilio actual:	Glaciar Cipreses 301, Los Andes			Teléfono	977450460.		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	K° B.	Establecimiento	Liceo Mixto Básica N° 2.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	09/05/25.	2. Fecha de la entrevista:	26/03/26.
Nombre:	Carolina Perez Muñoz.	Nombre:	Carolina Perez
Relación con el/la estudiante:	madre	Relación con el/la estudiante:	madre
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	
3. Fecha de la entrevista:		4. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Relación con el/la estudiante:		Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	09/05/25	2. Fecha de la entrevista:	26/03/26.
Nombre:	Sofia Ríos Flores	Nombre:	Sofia Ríos Flores
Rol/cargo:	Educadora Diferencial.	Rol/cargo:	Educadora Diferencial.
3. Fecha de la entrevista:		3. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Rol/cargo:		Rol/cargo:	

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

* Ingreso a Programa de Integración Escolar (PIE).

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☑ No ☐ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida		
Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo)	urgencia, Rpa de latidos.	
Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 3,500.	Talla: 51
Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto: Sin antecedentes relevantes.		

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	~~Sí~~	No	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas	~~Sí~~ / No

Observaciones:
Presentó fiebres altas al 1 año y 5 meses.
Los primeros días presentó bajo de peso, ya que a la madre no le bajaba leche materna.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 m.	Se sienta sólo/a: 7 m.	Camina sin apoyo: 1 a
Primeras palabras: —	Primeras frases: —	Se viste solo/a: 5 a.

Controla esfínter vesical Diurno: 3 a Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: 3 a Nocturno: ✓

Observaciones: Sin observaciones.

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☑ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo				**Su tono muscular general se aprecia:** ☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico				
En relación con su motricidad gruesa se aprecia:								
Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No
En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:								
Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No
En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)								
Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos				~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones				~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano				~~Sí~~	No

Observaciones: Sin observaciones.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	~~Sí~~	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Sí~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	~~No~~	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Sí~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	~~No~~
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	~~Sí~~	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	~~No~~	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~

Observaciones: Sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): —					
Observaciones:					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada			**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada
Observaciones: * Personas extrañas: lo estudiante piensa que todos los personas son sus amigos.					

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		
El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Piel atópica - Alergia Primaveral y cutánea. Recibe tratamiento de medicamentos: dorfenamina y levocetrizina					
Alimentación: ☑ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)					
Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad					
Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 hrs					
☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor			Duerme: ☐ solo ☑ acompañado (Especifique): madre		
Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*					
☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a) Otro:					
Observaciones: Selectiva para comer, no le gusta mezclar su comida. no le gustan los cítricos.					

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Carolina Pérez.	Madre	38.	universitaria	constructora / D. casa.
2. Gustavo Muñoz.	Padre	50	tec. profesio.	Planto de hormigones.
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Por parte de la familia materna.. la abuela padece de depresión endógena, mientras que un tío fue diagnosticado en edad adulta. con TDAH con hiperfoco.
Por parte de la familia paterna, un tío presento un diagnóstico de TOC. (trastorno obsesivo - compulsivo).

Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	3	Asistió a jardín infantil/escuela de lenguaje.		Sí	No
N° de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: trabajo de la madre.					
Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s)	Motivo: —	

Situación actual											
Nivel/curso actual	K° B.		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No
Asiste regularmente	Sí	No	Asiste con agrado	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	Sí	No	Amigos (as)	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☑ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

La madre comenta que Eleonor presenta alergia. pero aún no se sabe especificamente a que, por lo que dentro de un año (cuando cumpla 7 años) se le realizará examen para identificar las alergias de Eleonor.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY